RELIEF：非 IPF 进展性 ILD 的 II b 期试验

随机 · 双盲 · 安慰剂对照 | 德国 17 中心
127 例随机：吡非尼酮 64 例 / 安慰剂 63 例
CTD-ILD 、纤维化 NSIP 、慢性过敏性肺炎、石棉肺
既有治疗下仍进展；试验药加于原治疗
主要终点： 48 周 FVC 占预计值百分比的绝对变化
吡非尼酮递增至 801 mg ，每日 3 次

适用边界：四类疾病的混合人群；不能认定各亚型独立获益

Behr J, et al. Lancet Respir Med. 2021;9:476–486. PMID:33798455 | DOI:10.1016/S2213-2600(20)30554-3

主要分析提示获益，效应大小仍有不确定性

分析（均为已发表汇总数据）	结果	统计边界
主要： ITT 秩 ANCOVA	P=0.043	SSD 插补；死亡最差秩
Hodges–Lehmann 组间差	1.69 个百分点	95%CI −0.65 ～ 4.03
预设纵向斜率敏感性分析	3.53 个百分点	95%CI 0.21 ～ 6.86

差值方向：正值支持吡非尼酮；不同估计 / 检验方法应分别解读。

提前终止 + 缺失数据：敏感性分析不能替代主要分析

Behr J, et al. Lancet Respir Med. 2021;9:476–486. PMID:33798455 | DOI:10.1016/S2213-2600(20)30554-3

安全性与局限决定解读边界

死亡： 1/64 vs 5/63 （吡非尼酮 vs 安慰剂）
严重感染类事件： 5/64 vs 10/63
仅为描述性事件计数；不证明死亡获益或安全等效
招募缓慢触发无效性中期分析，研究提前终止
缺失数据、人群异质性与样本量限制外推
全文已核验；附录未获取；技术测试件；不替代正式临床推荐

谨慎支持进一步研究；不能据此宣称生存获益或指南推荐

Behr J, et al. Lancet Respir Med. 2021;9:476–486. PMID:33798455 | DOI:10.1016/S2213-2600(20)30554-3